

KC桌面——外资精译

GS：GS调研，每月50美元自付额，700万患者将涌入减重药市场

受去年 LLY 和 Novo 与美国政府达成的最惠国药品定价协议推动，2026 年 7 月 1 日，CMS 推出了一项持续至 2027 年 12 月的新临时计划，即 GLP-1 桥梁计划。受益人可以以每月 50 美元的共付额获得 Medicare 对肥胖症 GLP-1 药物的覆盖——包括 Novo 的 Wegovy（注射剂和口服剂型）以及 LLY 的 Zepbound Kwikpen 和 Foundayo 口服片。该计划的推出消除了历史上禁止 Medicare 覆盖仅用于减肥药物的法定障碍，为抗肥胖药物市场带来了前所未有的放量。

在 Medicare 放量前夕，我们就医生对该计划的采用预期以及所覆盖 GLP-1 药物的偏好，调研了 25 名医生。我们总结出以下关键点

- 医生预计，在 2026 年计划推出后及约一年后，符合条件的患者对桥梁计划的采用率分别约为 31% 和 45%。
- 患者对该计划的兴趣很高，医生指出，38% 的符合条件的患者群体已表达了对 GLP-1 用于肥胖症的兴趣。
- LLY 的 Zepbound Kwikpen 预计将占据最高份额（44%），其次是 Novo 的 Wegovy 注射笔（27%）、Novo 的 Wegovy 口服片（16%）和 LLY 的 Foundayo（13%）。
- 实现最大减重是处方决策的首要驱动因素。有趣的是，口服与注射的偏好是一个较少被提及的因素，且没有医生将食物影响/空腹要求列为障碍。
- 获得事先授权被视为该计划最显著的物流瓶颈。

我们认为整体调研结果与我们 AOM 市场模型基本一致。我们估计 2026 年 Medicare 渠道收入约为 26 亿美元，2027 年增至约 80 亿美元，其中疗效更高的注射剂占据大部分份额。不过，我们预计读者将在未来几个月密切关注处方趋势（例如，Zepbound Kwikpen 在 DTC 和政府渠道中的整体处方量增长）。从整体放量角度看，鉴于被调研医生预期渗透率高且患者兴趣浓厚，我们认为结果对 LLY 和 Novo 均属利好。

Medicare 放量——KOL 调研

我们调研了 25 名医生（13 名内分泌科医生，12 名初级保健/内科/家庭医学医生——统称为 PCP），他们需满足以下条件：1) 治疗 Medicare 人群中无糖尿病的肥胖症患者，2) 曾开具过多种 GLP-1 药物处方，3) Medicare 患者至少占其总患者群体的 20%，4) 根据计划标准，估计其至少有 50 名 Medicare 患者符合 GLP-1 桥梁计划条件。

我们总结出以下关键点

放量。我们的调研显示，医生平均预计在 2026 年下半年计划推出后不久及约一年后，符合条件的患者对 GLP-1 Medicare 桥梁计划的采用率分别约为 31% 和 45%。假设约有 1500 万患者符合该计划条件，这意味着桥梁计划启动一年后约有 700 万患者接受治疗。医生进一步指出，平均而言，其符合条件的患者群体中有 38% 已在 Medicare 桥梁计划之前表达了对 GLP-1 的兴趣。根据我们的调研，这比已通过非 Medicare 渠道接受治疗的患者比例高出 15 个百分点。虽然这意味着采用率高于我们 2026 年 Medicare 渠道 26 亿美元收入预测所隐含的水平（假设 2026 年剩余时间平均治疗持续时间为 3.5 个月，每月费用 245 美元，对应约 350 万患者），但我们承认调研存在局限性，包括样本集偏差——参与本次调研的医生更可能是早期采用者/活跃的 GLP-1 处方者。证据是，被调研医生报告称，其符合条件的患者中约有 23% 已通过非 Medicare 渠道（即 DTC/自费）使用 GLP-1 药物。然而，根据处方数据和公司评论（LLY 估计目前约有 10-20% 的 LLY Direct 患者可能符合 Medicare 桥梁计划条件），我们认为该人群目前的 GLP-1 使用率较低。

可用药物之间的份额分配。关于份额分配，在 Medicare 桥梁计划覆盖的现有选项中（Novo 的 Wegovy 注射剂和口服剂型，以及 LLY 的 Zepbound Kwikpen 和 Foundayo 口服片），医生平均预计 LLY 的 Zepbound Kwikpen 将占据最高份额（44%），其次是 Novo 的 Wegovy 注射笔（27%）、Novo 的 Wegovy 口服片（16%）和 LLY 的 Foundayo（13%）。这与医生对桥梁计划前符合条件的患者通过非 Medicare 渠道接受 GLP-1 治疗的份额分配估计基本一致（Zepbound 45%，Wegovy 注射笔 34%，Wegovy 口服片 15%，Foundayo 6%）。作为参考，当前的 TRx 处方数据显示，假设 Wegovy 口服片和 Foundayo 的捕获率分别为 60% 和 90%，则 Zepbound/Wegovy 口服片/Wegovy 注射笔/Foundayo 口服片之间的份额分配为 52%/25%/21%/2%。

处方决策驱动因素。实现最大减重的能力是处方决策最常见的首要驱动因素，其次是耐受性，而口服/注射偏好则是一个较少被提及的驱动因素。有趣的是，没有医生将食物/空腹要求列为处方障碍。

■ 预期瓶颈。医生预计，获得事先授权将是最显著的物流瓶颈，其次是包括集中处理和合适的患者筛选在内的一系列其他因素。

\- 治疗持续时间。医生报告称，符合条件的患者群体（此前通过非 Medicare 渠道使用 GLP-1）的平均观察治疗持续时间约为 12 个月。鉴于我们之前的调研表明，可及性/成本是停药的主要原因，我们认为患者自付 50 美元可能会提高患者依从性，并成为收入的顺风。

影响：公司情况更新

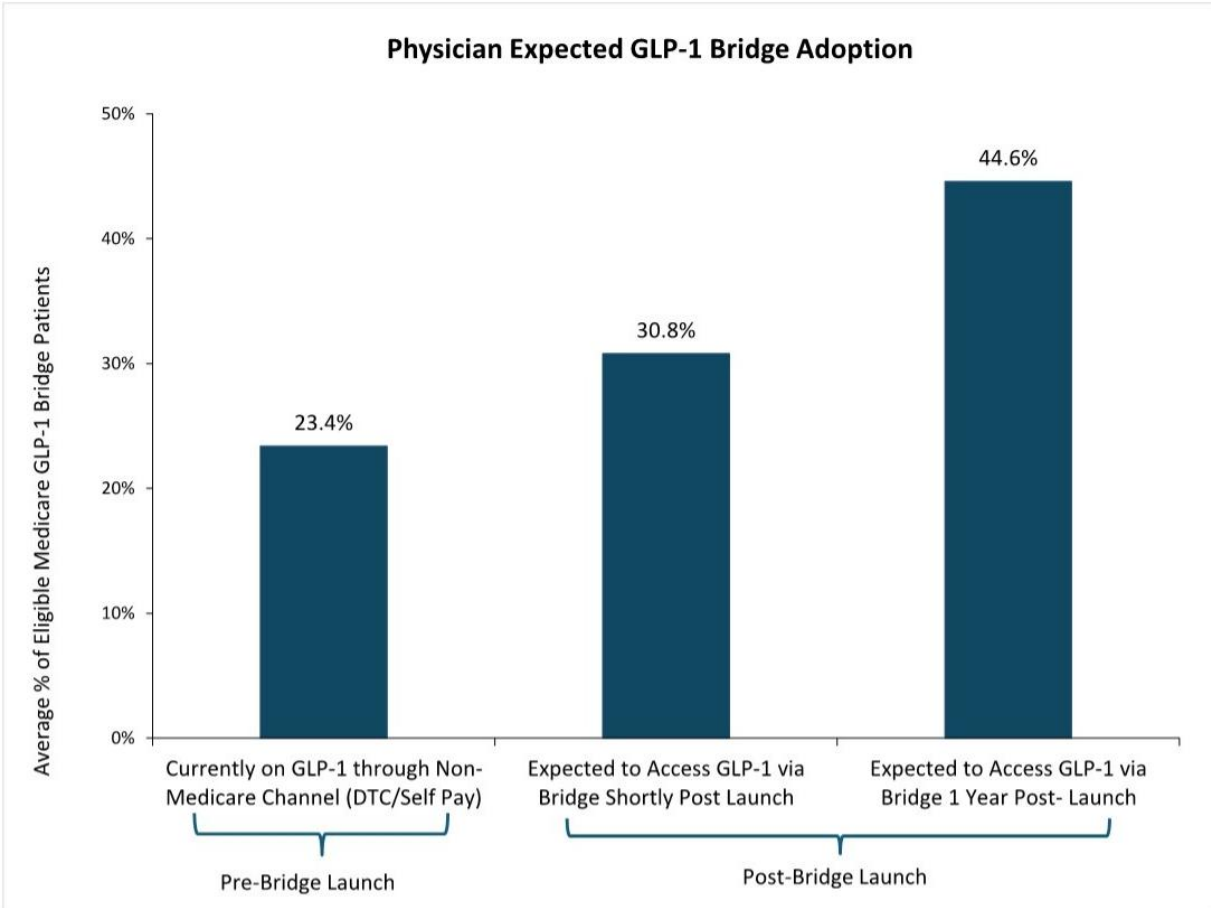
我们认为整体调研结果与我们全球抗肥胖药物市场模型基本一致。我们估计 2026 年 Medicare 渠道收入约为 26 亿美元，2027 年增至约 80 亿美元，其中疗效更高的注射剂占据大部分份额。不过，我们预计读者将在未来几个月密切关注处方趋势（例如，Zepbound Kwikpen 在 DTC 和政府渠道中的整体处方量增长）。综合考虑价格和数量变化，我们示意性地计算出 2026 年下半年的增量收入超过 20 亿美元，2027 年超过 60 亿美元（假设 1500 万桥梁计划患者，并根据近期处方数据，采用 Zepbound 400 美元、Wegovy 注射笔 349 美元、Wegovy 口服片 175 美元和 Foundayo 189 美元的 DTC 月均价格加权平均）。

我们认为，该调查对 LLY 和 Novo 均构成积极信号：预计 Zepbound 将保持领先份额，而 Wegovy 口服药的食物效应/空腹要求不被视为障碍。从整体用量来看，根据受访医生对高渗透率的预期及患者的高兴趣度，我们认为两家公司的结果均为正面。

调查问题：公司情况更新

在 Bridge 计划下，您目前有多少比例的 Medicare 合格患者正通过非 Medicare 渠道接受 GLP-1 治疗？您预计在 7 月 1 日 Bridge 计划启动后不久，有多少比例的患者会通过该计划开始 GLP-1 治疗？约 1 年后呢？

图表 1：医生预计 Medicare GLP-1 Bridge 计划推出后将出现显著采用率



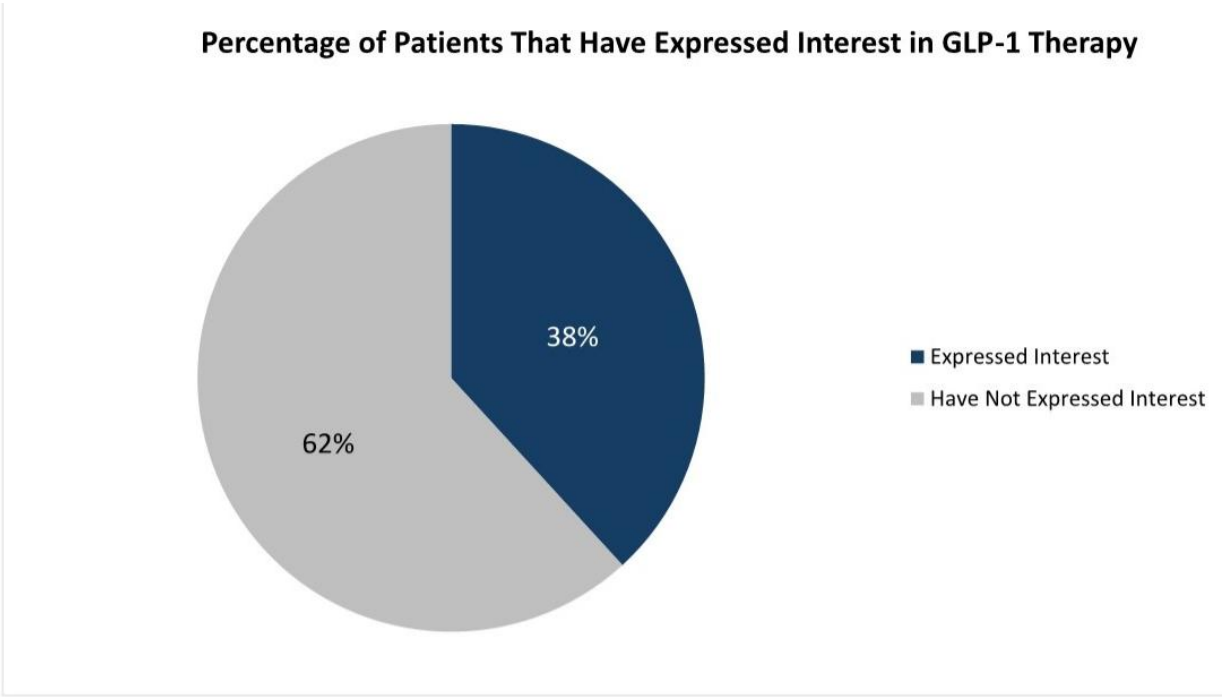
图表 1

在此我们承认调查数据中的一些细微差别——受访者表示，平均23%的患者目前正通过非Medicare渠道（推测为自费）接受GLP-1治疗，并预计在Bridge计划启动后不久及启动后1年，分别约有31%和45%的Medicare Bridge计划合格患者将加入该计划——假设Medicare合格总人口约为1500万，这意味着约有350万、500万和700万患者正在接受或已获处方GLP-1用于减重。在此，我们认为样本中当前GLP-1使用率高于更广泛的Medicare人群，因为我们的调查设计旨在涵盖拥有大量Medicare患者群体且具备肥胖治疗经验的医生。

虽然这表明用量存在顺风因素，但我们提醒，假设现有GLP-1使用人群为自费，其价格高于Medicare商定的每月245美元，则同时存在价格逆风因素，该因素最初将从收入角度抵消用量增长。

您目前未使用GLP-1药物的Medicare患者中，在BRIDGE计划启动前，有多大比例已表达了对GLP-1治疗的兴趣？

图表2：许多符合条件的Medicare患者已表达对GLP-1的兴趣



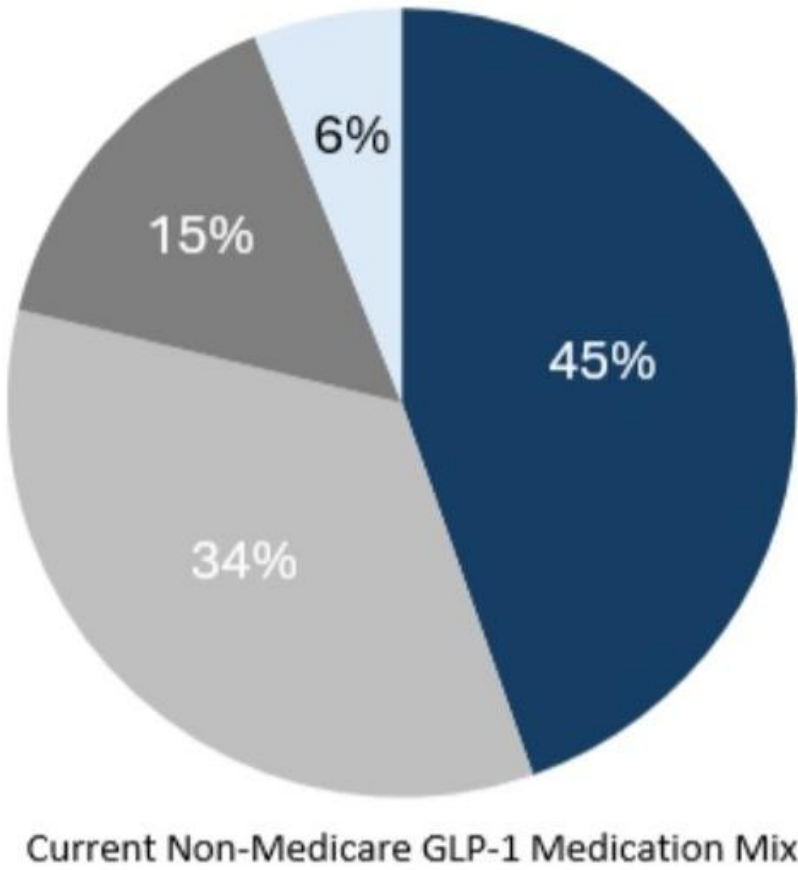
图表 2

在目前通过非Medicare渠道接受GLP-1治疗的Medicare患者中，以下每种药物的使用比例是多少？（下方左侧饼图）

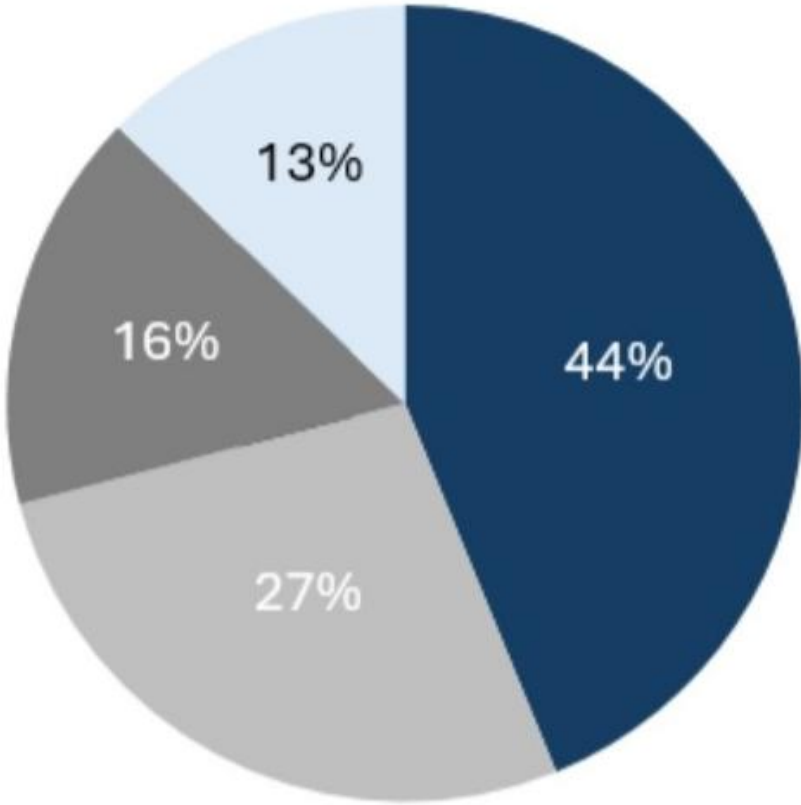
- 在您预计通过Bridge计划接受GLP-1治疗的Medicare患者中，您预计有多大比例会使用以下选项进行治疗？（下方右侧饼图）

图表3：Bridge计划下GLP-1药物之间的份额分配预计基本保持一致

Bridge计划下GLP-1药物之间的份额分配预计基本保持一致



图表 3



Expected Medicare GLP-1 Medication Mix

图表 4

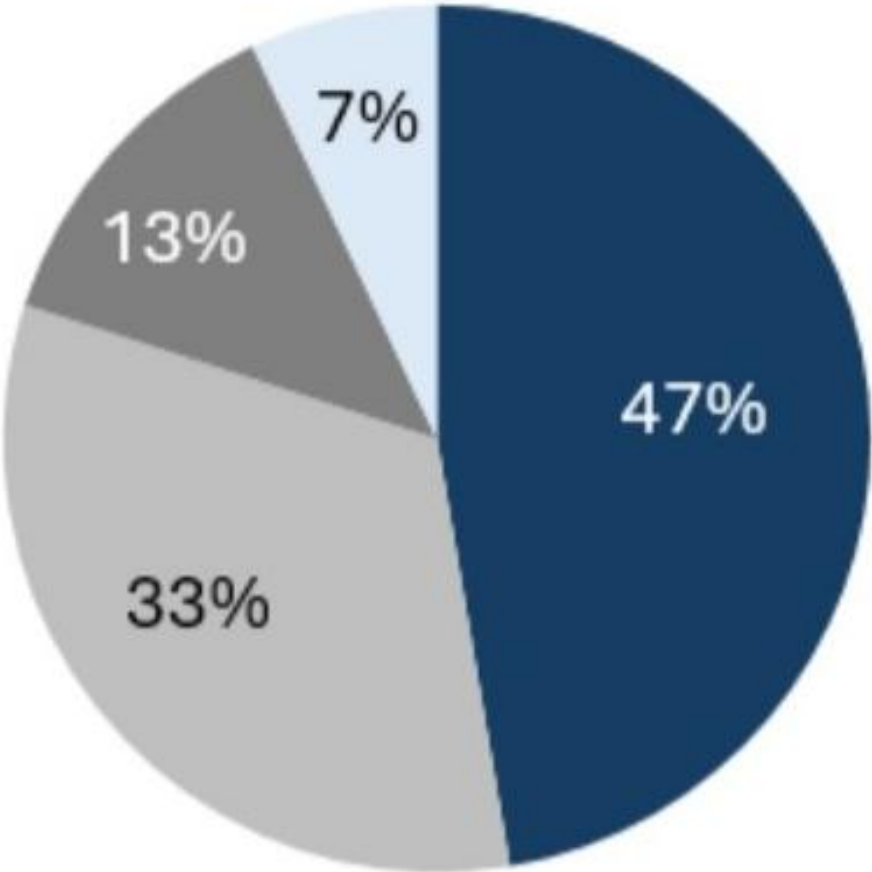
我们在此指出，医生平均预计注射剂与口服药的比例约为70/30，而Novo近期的市场调研显示Medicare患者偏好口服药且口服药趋势强劲，尽管我们注意到这与我们的模型更为一致——我们预计2026年潜在Medicare渠道收入的85%将归属于注射剂，因其疗效更高且感知价值更高（例如更高的DTC成本）。然而，我们认为，虽然Novo的研究显示Medicare患者偏好口服药，但医生——尤其是内分泌科医生（如下所述）——可能更偏好疗效更高的疗法，因此倾向于注射剂。因此，在患者主导的渠道（自费）中，我们可能会看到相反的情况。

有趣的是，对于口服AOM，内分泌科医生似乎更青睐Foundayo而非Wegovy口服药。这可能源于在2型糖尿病治疗中使用Rybelsus的经验，Bridge计划后份额从65:35（Wegovy口服药占优）变为45:55（Foundayo占优）。对于初级保健医生，Wegovy口服药的初始上市似乎使其占据优势，当前份额为77:23（Wegovy口服药占优），Bridge计划后变为69:31。

因此，口服药市场动态的一个关键驱动因素也可能是专科内分泌科医生与初级保健医生的处方比例，我们预计这在Medicare和非Medicare渠道中相似。

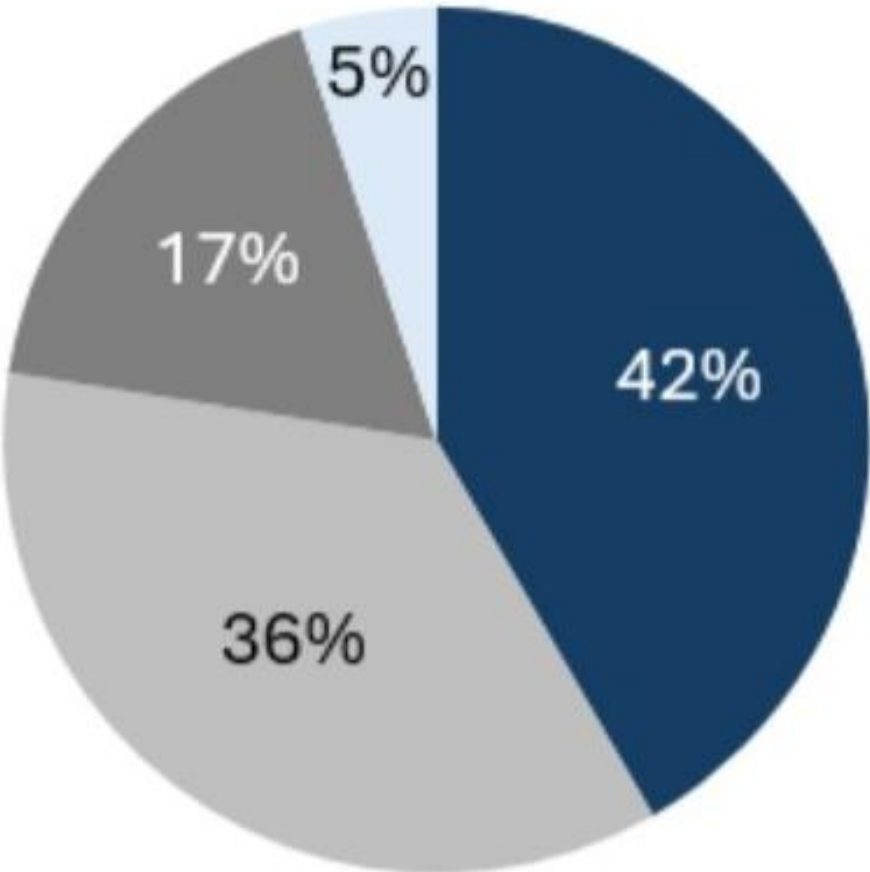
图表4：内分泌科医生与初级保健医生的份额分配明细

Bridge计划前市场份额 - 内分泌科



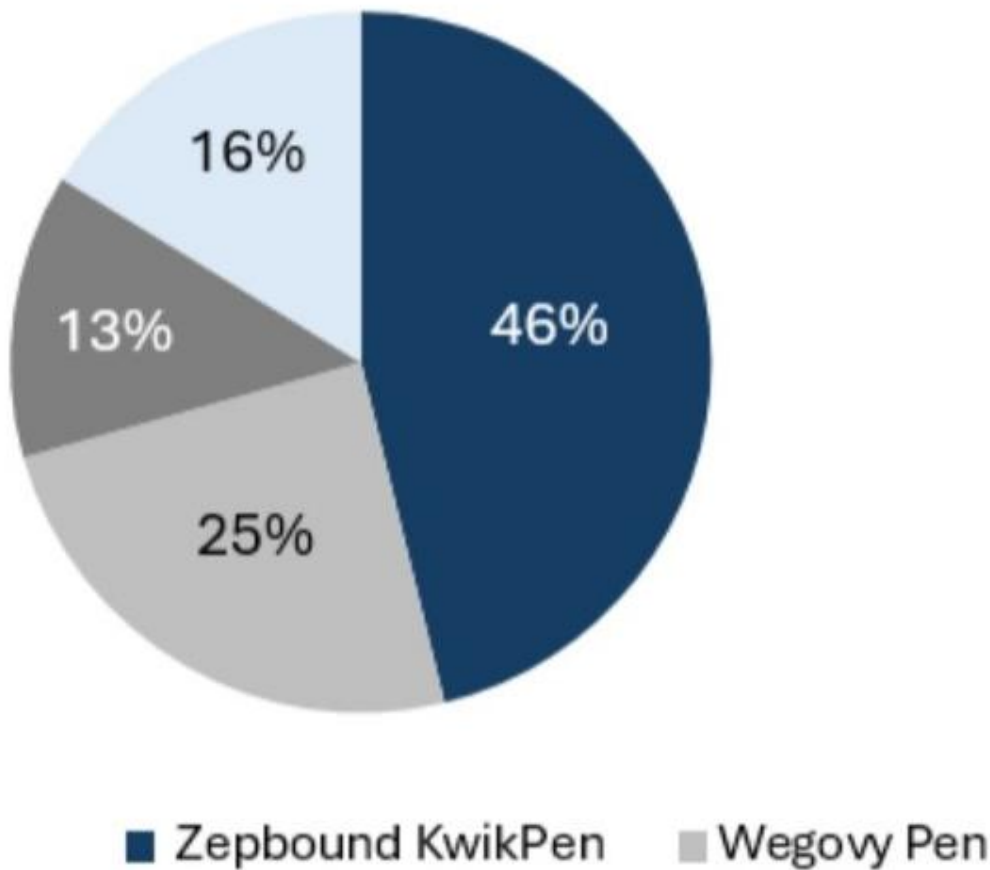
图表 5

Bridge计划前市场份额 - 初级保健医生



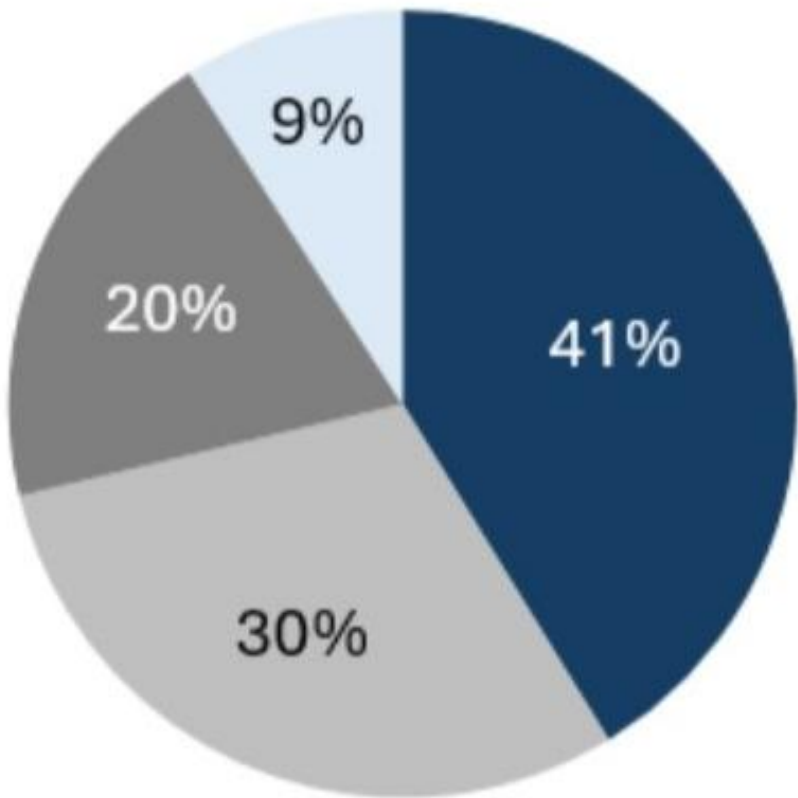
图表 6

Bridge计划后市场份额 - 内分泌科



图表 7

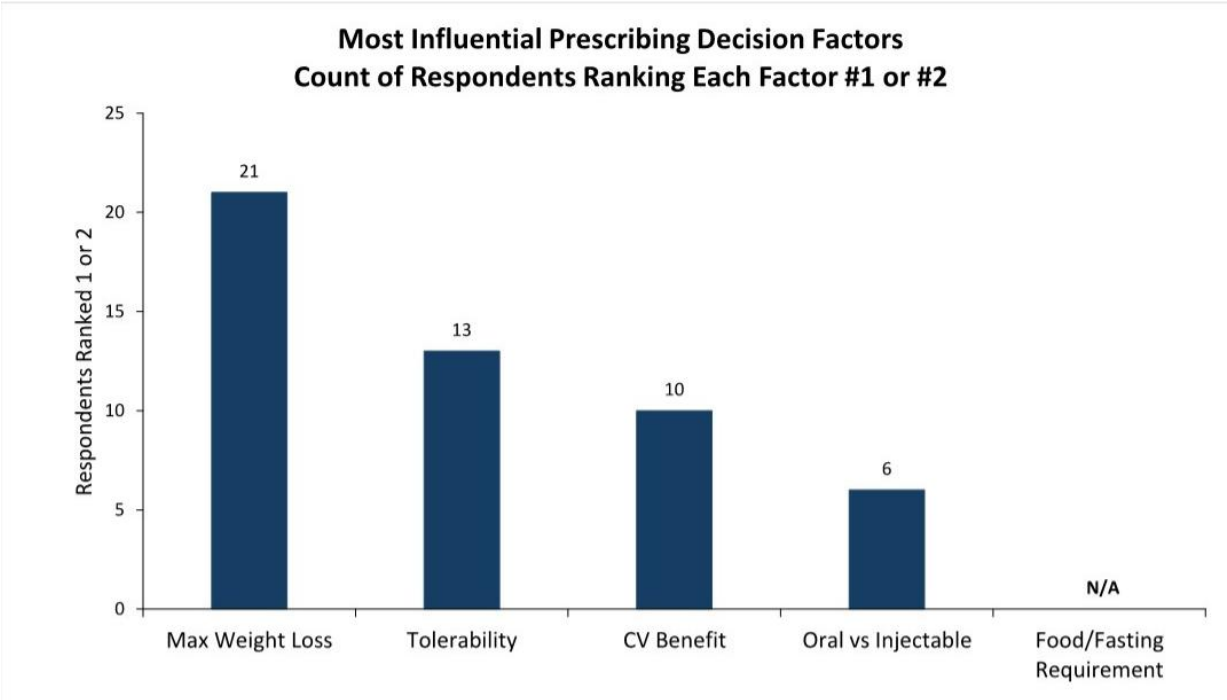
Bridge计划后市场份额 - 初级保健医生



图表 8

请对以下影响您对Medicare患者处方决策的因素进行排序（1为最重要，5为最不重要）

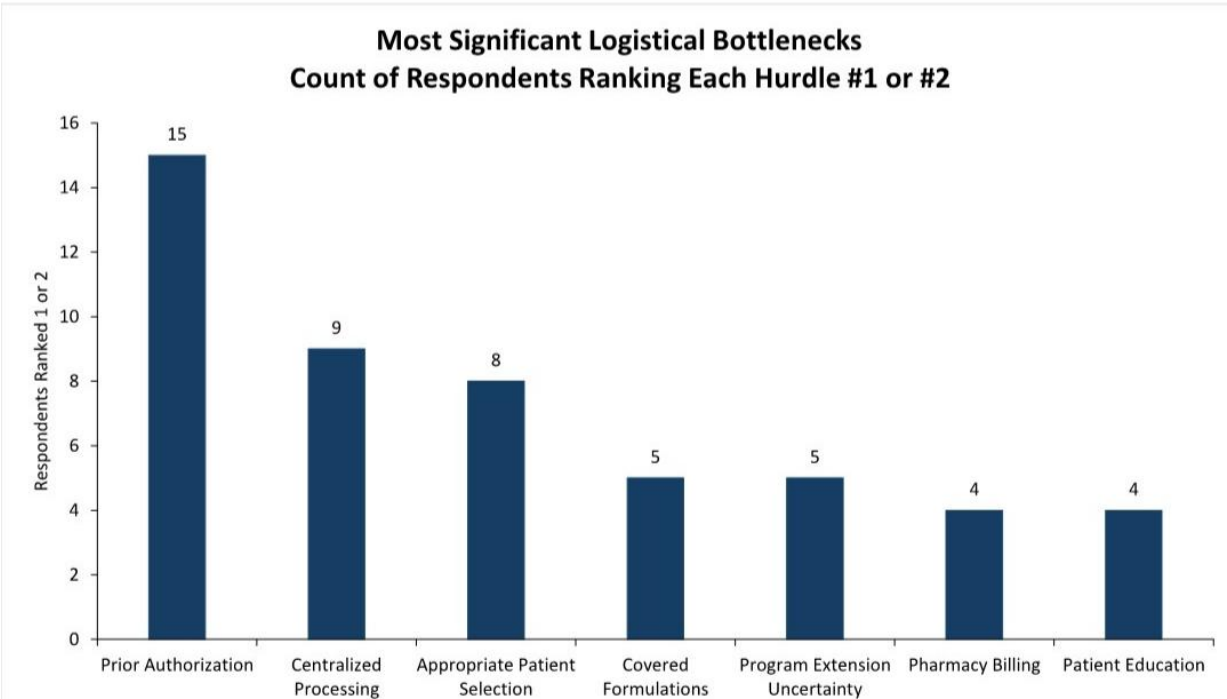
图表5：减重疗效和耐受性是处方决策的主要驱动因素



图表 9

您认为以下哪项将是最大的后勤障碍/瓶颈（1为最重要，7为最不重要）

图表6：预计事先授权将成为最大瓶颈



图表 10

虽然我们样本中的医生希望接受治疗的患者比例随时间显著增加，但事先授权似乎是我们样本群体识别出的关键障碍。根据Bridge处方流程，在所有情况下，医生必须通过Bridge提交治疗的事先授权（参见此处），因此，尽管医生对患者接受治疗的预期对整个群体而言是乐观的，但使用管理标准可能会减缓采用速度。

对于通过非Medicare渠道接受GLP-1治疗的患者，您观察到的治疗持续时间是多少？

图表7：医生报告的平均观察治疗持续时间（针对此前通过非Medicare渠道使用GLP-1的合格患者群体）约为12个月。

估值与不确定性

LLY：公司情况更新

我们对礼来更新公司观点。我们采用28.0倍市盈率，基于我们对Q5-Q8每股收益的预测。

节奏变化不确定性：肥胖市场年度价格降幅超预期。因外部竞争或内部对现有及管线资产执行不力导致市场份额低于预期，可能对我们的预测构成节奏变化不确定性。管线资产数据不及预期可能导致我们中期至长期预测大幅节奏变化，并导致公司估值倍数压缩。

Novo：公司情况更新

我们对诺和诺德更新公司观点。。我们的自下而上DCF分析显示每股估值为309丹麦克朗。我们使用7.1%的加权平均资本成本和-2%的终值增长率。在倍数基础上，我们认为诺和诺德应基于我们对2027年每股收益的预测以14.5倍市盈率交易，对应每股310丹麦克朗。因此。，按当前汇率折算。

；(2) CagriSema 峰值销售额高于预期。节奏变化不确定性——(1) 若 CagriSema 和/或 amycretin 开发失败，则存在临床不确定性；(2) Wegovy/Ozempic 生产扩产慢于预期；(3) 竞争对手肥胖症数据强于预期，尤其是基于口服小分子 GLP-1 的资产；(4) 更深且持续的价格不确定性。